

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5011821-67.2025.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**RECORRIDO:** IVONE FERREIRA SOUZA**RECORRIDO:** RAPHAEL LUIZ FAGUNDES DOS SANTOS BREVES

PROCESSO CIVIL - SAÚDE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - DPOC - OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA - - A PROBABILIDADE DO DIREITO DECORRE DA INCORPORAÇÃO DO SERVIÇO AO SUS - A URGÊNCIA É DEMONSTRADA PELO LAUDO MÉDICO CORROBORADA PELO PARECER DO NAT - ART 300 DO CPC - À LUZ DO TEMA 793 DO STF, A TUTELA DEVE SER DIRECIONADA EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO PELO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

**ACÓRDÃO**

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, unicamente para para determinar a responsabilidade primária do Estado do Rio de Janeiro e do Município pelo cumprimento da medida determinada pelo juízo de origem. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

**5011821-67.2025.4.02.5101****510015727756 .V3****RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5011821-67.2025.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**RECORRIDO:** IVONE FERREIRA SOUZA**RECORRIDO:** RAPHAEL LUIZ FAGUNDES DOS SANTOS BREVES**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso de medida cautelar com pedido de efeito suspensivo apresentado pela União contra a decisão do juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus forneçam à autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), tratamento de oxigenioterapia domiciliar, conforme indicado no laudo médico do Evento 1, ANEXO2, fl. 22 (modalidade estacionária e portátil, com via de acesso por cateter nasal).

A decisão de 1ª instancia foi mantida por atender aos parâmetros legais.

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

**VOTO**

Analisando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

O NAT emitiu parecer (evento 6, PARECER1) no sentido de que *"a **oxigenoterapia domiciliar, com concentrador de oxigênio estacionário e portátil e cateter nasal está indicada ao manejo do quadro clínico da Autora - hipoxemia crônica, compatível com doença pulmonar obstrutiva crônica, dependente de oxigenoterapia**". Bem como ressaltou que está coberto pelo SUS: "Quanto à disponibilização, **salienta-se que o tratamento com oxigenoterapia prolongada está coberto pelo SUS**, conforme Tabela Unificada do Sistema de Gerenciamento de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP, na qual consta oxigenoterapia, sob o código de procedimento: 03.01.10.014-4, para área ambulatorial, hospitalar e de atenção domiciliar."*

A Portaria nº 29/2012 do Ministério da Saúde tornou pública a **decisão de incorporar a oxigenoterapia domiciliar para o tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica no SUS**. Por seu turno, a Portaria Conjunta nº 19/2021 aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, prevendo em seu art. 3º que compete aos gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, conforme a sua competência e pactuações, estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com essa doença.

**Tratando-se de serviço já incorporado ao SUS, mas não fornecido pelo Estado, tem-se por configurada falha administrativa** apta a autorizar a intervenção judicial para garantir o direito da parte autora.

A probabilidade do direito decorre da incorporação do serviço ao SUS, enquanto a urgência é demonstrada pelo laudo médico.

Considerando que o quadro fático se mantém inalterado, reporto-me a decisão anterior proferida neste instrumento, mantendo a tutela deferida na origem e indeferindo o efeito suspensivo pretendido.

Por outro lado, à luz do 793 do STF, deve ser afastada a atribuição de responsabilidade primária à União, pois a responsabilidade pelo cumprimento do PCDT da DPOC e pelo fornecimento da oxigenoterapia domiciliar é da responsabilidade dos Estados e Municípios.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO**, unicamente para determinar a responsabilidade primária do Estado do Rio de Janeiro e do Município pelo cumprimento da medida determinada pelo juízo de origem. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11º do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.